

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Hydatid Cyst of the Liver

معلومات الإقرار – نسخة المريض
كيس الديدان الشريطية في الكبد

1. What is a hydatid cyst of the liver?

This procedure involves the surgical removal or drainage of a liver cyst which contains parasites (a hydatid cyst).

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

1. ما هو كيس الديدان الشريطية في الكبد؟

في هذا الإجراء يتم استئصال أو سحب و تصريف محتويات كيس في الكبد يحتوي على طفيليات (الدودة الشريطية).

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .

اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.

إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انسداد للشعب الهوائية الصغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Specific risks:

- Difficulty passing urine after the operation and may need catheter passed into the bladder until the bladder can empty normally.
- Deep bleeding in the abdominal cavity could occur and this may need fluid replacement or further surgery.
- Infections such as pus collections can occur in the abdominal cavity. This may need surgical drainage.
- Bile can leak from the liver and cause problems needing drainage or further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after the surgery and this may cause building up of fluid in the bowel with bloating in the abdomen and vomiting. Further treatment may be necessary for this.
- A weakness can occur in the wound with the development of a bursting or herniation. This may require further surgery.
- Healing of the wound may be abnormal. The wound can be thickened and red and the scar may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel obstruction. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

- قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول بعد الجراحة ، مما قد يتطلب وضع أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة حتى تعود المثانة للإفراغ الطبيعي للبول.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سوائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- الإصابة بالتهاب سوائل البطن كتجمعات للصدید في التجويف البطني مما قد يتطلب تفريغ الصدید جراحياً .
- قد تتسرب المادة الصفراء من الكبد مسببةً مشكلات تتطلب سحبها وتصريفها أو جراحة أخرى.
- قد تصاب حركة الأمعاء بالانسداد وبطء في الحركة بعد العملية مما يسبب تراكم السوائل في الأمعاء وانتفاخ للبطن وتقيؤ. قد يتطلب الأمر علاج آخر.
- قد يظهر ضعف في موقع الجرح مما يؤدي تمزق أو ظهور فتق قد يتطلب إصلاح ذلك جراحة أخرى.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي . قد تزداد سماكته ويصبح لونه أحمر ، وقد يكون الندب مؤلماً
- قد تحدث التصاقات (أحزمة من الأنسجة المتندبة) وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب والرئة والتخثرات الدموية.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
